1

Antineoplastik İlaçlar

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ŞERMET

33 سؤال	**18** أساسي
15 للمراجعة	**20** امتحان

18

الأسئلة		
ÖR (+) meme kanseri olan postmenopozal hastada tamoksifen kullanılmasının temel nedeni nedir?	K6-26 · 45	01
Prostat kanseri tedavisinde kullanılan "androjen reseptör antagonisti" antiandrojen ilaç hangisidir?	K6-26 · 46	02
Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi alkilleyici bir ajandır?	F26 · 7	03
Malign melanoma tedavisinde kullanılan "CTLA-4 immün kontrol noktası inhibitörü" antineoplastik ilaç hangisidir?	F26 · 8	04
Kolorektal kanser tanısı konulan hastaya tümör cerrahisi sonrası planlanan antineoplastik kemoterapi biçimi hangisidir?	K26 · 1	05
Antianjiyogenik etkinliği de olan, renal hücreli karsinom ve hepatoselüler karsinomda kullanılan çoklu kinaz hedefli antineoplastik ilaç hangisidir?	K26 · 5	06
Androjen reseptör antagonisti olup prostat kanseri tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir?	K6-25 · 52	07
Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi bir programlanmış ölüm (PD-1) noktası inhibitörüdür?	F25 · 16	08
Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tanısı konulan 60 yaşında kadın hastanın tedavisi için en uygun ilaç hangisidir?	K25 · 69	09
ABVD tedavisi alan Hodgkin lenfoma hastasında pnömonitis gelişiyor; kombinasyondaki hangi ilacın bu yan etkiyi oluşturma potansiyeli en fazladır?	K25 · 70	10
İlerlemiş prostat kanseri tedavisinde kullanılan GnRH analoğu hangisidir?	K6-24 · 57	11
Aşağıdaki "akıllı ilaç – etki mekanizması" çiftlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?	K24 · 81	12
Hem östrojenik hem antiöstrojenik aktiviteye sahip, ÖR(+) meme kanserinde kullanılan Selektif Östrojen Reseptörü Modülatörü (SERM) antineoplastik ajan ...	K23 · 89	13
Aşağıdaki hedeflerden hangisi nivolumab tarafından inhibe edilir?	K23 · 91	14
İlerlemiş prostat kanserinde GnRH reseptörlerinin yarışmalı antagonisti olan ilaç hangisidir?	K6-22 · 56	15
Östrojen ve progesteron reseptörü pozitif meme karsinomu çıkarılan 50 yaşındaki kadın hangi ilacı alabilir?	K6-21 · 52	16
Gompertzian modelini izleyen solid bir tümörde hangisi kemoterapötiklerle daha yüksek oranda hücre öldürülmesini desteklemez?	K21 · 56	17
Aşağıdaki antiandrojenlerden hangisi androjen reseptör antagonistidir ve prostat kanserinin tedavisinde kullanılır?	F20 · 83	18

Kemik iliği nakli öncesinde kemik iliği mobilizasyonu için hangi ilaç kullanılabilir?	**F26 · 11**	19
Başlıca dihidrofolat redüktaz ve timidilat sentaz enzimlerini inhibe eden, çok çeşitli hematolojik ve solid tümörlerde kullanılan antimetabolit hangisidir?	**K26 · 3**	20
Siklofosfamid alan hastada kemoterapiye bağlı miyelotoksisite sonucu gelişen şiddetli nötropenide hangi ilaç kullanılabilir?	**K26 · 12**	21
Kemoterapiye bağlı ciddi lökopenide kemik iliğinin nötrofil üretimini hızlandırmak için hangi ajan tercih edilir?	**K26 · 16**	22
Kemoterapiye bağlı emezis tedavisinde kullanılan 5-HT3 ilacı hangisidir?	**K26 · 19**	23
Kemoterapiye bağlı geç dönem kusmada granisetron ve deksametazona eklenen üçüncü ilaç hangisidir?	**K5-25 · 63**	24
Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin neden olduğu emesise karşı kullanılan 5-HT3 antagonistidir?	**K4-25 · 7**	25
Kemik iliği transplantasyonunda yardımcı ilaç olarak ve kanser hastalarında nötropeninin hafifletilmesinde kullanılan ilaç hangisidir?	**F25 · 15**	26
Antiemetikler için hangisi yanlıştır? (Metoklopramid seçici D2 antagonistidir, başka reseptöre etkisi yoktur)	**K5-24 · 59**	27
Siklofosfamidin etkisi aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin aracılığı ile gerçekleşir?	**K24 · 79**	28
Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı azaltan bir peptid (substans P / NK1) antagonisti hangisidir?	**BF23 · 72**	29
Küçük hücreli akciğer kanserinde ilk kemoterapi kürü sırasında akut bulantı-kusmayı önlemek için en iyi üçlü kombinasyon hangisidir?	**K5-22 · 57**	30
İnsan keratinosit büyüme faktörünün rekombinant formu olan ve ağır oral mukozitin insidansını ve süresini azaltan ajan hangisidir?	**B21-2 · 90**	31
Şiddetli kemoterapi kaynaklı nötropeni gelişen hastada hangisi kullanılabilir?	**B21-2 · 92**	32
Aşağıdaki sitoprotektif ajanlardan hangisi rekombinant insan keratinosit büyüme faktörüdür ve antineoplastik ilaca bağlı oral mukozitin tedavisinde kullanılır?	**F21-1 · 42**	33

ملاحظات

45. **Östrojen reseptör pozitif meme kanseri olan postmenopozal bir hastada tamoksifen kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Selektif östrojen reseptör modülatörü olması ✓
B) Progesteron reseptör blokajı yapması
C) Aromataz inhibisyonu yapması
D) GnRH salınımını artırması
E) Prolaktin sekresyonunu baskılaması

K6-26 Kurul 2025–2026 • Soru 45

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

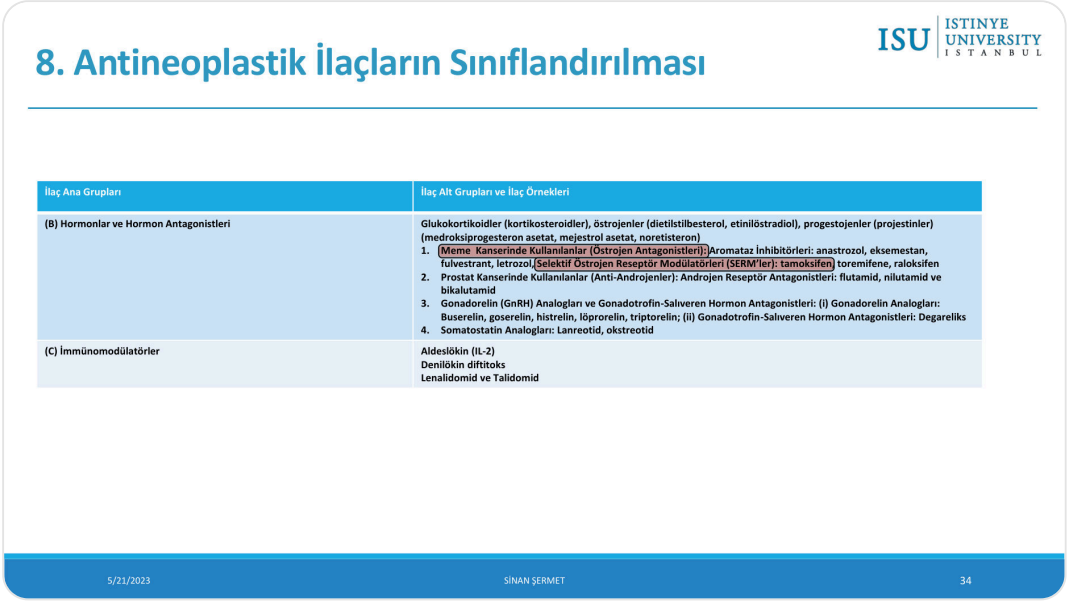
ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 5. سلايد 34 هنا بيقول إن tamoksifen من الـ SERM (معدِّلات مستقبل الإستروجين الانتقائية) اللي بتستخدم في سرطان الثدي.

الإجابة

A **Selektif östrojen reseptör modülatörü olması**

من الدرس **سلايد 34** 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması



8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(B) Hormonlar ve Hormon Antagonistleri	Glukokortikoidler (kortikosteroidler), östrojenler (dietilstilbesterol, etinilöstradiol), progestojenler (projestinler) (medroksiprogesteron asetat, mejestrol asetat, noretisteron) 1. Meme Kanserinde Kullanılanlar (Östrojen Antagonistleri): Aromataz İnhibitörleri: anastrozol, eksemestan, fulvestrant, letrozol, Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen toremifene, raloksifen 2. Prostat Kanserinde Kullanılanlar (Anti-Androjenler): Androjen Reseptör Antagonistleri: flutamid, nilutamid ve bikalutamid 3. Gonadorelin (GnRH) Analogları ve Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: (i) Gonadorelin Analogları: Buserelin, goserelin, histrelin, löprorelin, triptorelin; (ii) Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: Degareliks 4. Somatostatin Analogları: Lanreotid, oktreotid
(C) İmmünomodülatörler	Aldeslökin (IL-2) Denilökin diftitoks Lenalidomid ve Talidomid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

46. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi prostat kanseri tedavisinde kullanılan "androjen reseptör antgonisti" bir antiandrojen ilaçtır?**

A) Bikalutamid ✓
B) Finasterid
C) Siproteron
D) Oksimetholon
E) Siproheptadin

K6-26 · Kurul 2025–2026 · Soru 46

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 5. سلايد 34 هنا بيقول إن bikalutamid مضاد لمستقبل الأندروجين وبيتستخدم في سرطان البروستاتا.

الإجابة **A Bikalutamid**

من الدرس **سلايد 34** 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(B) Hormonlar ve Hormon Antagonistleri	Glukokortikoidler (kortikosteroidler), östrojenler (dietilstilbesterol, etinilöstradiol), progestojenler (projestinler) (medroksiprogesteron asetat, mejestrol asetat, noretisteron) 1. Meme Kanserinde Kullanılanlar (Östrojen Antagonistleri): Aromataz İnhibitörleri: anastrozol, eksemestan, fulvestrant, letrozol, Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifene, raloksifen 2. Prostat Kanserinde Kullanılanlar (Anti-Androjenler): Androjen Reseptör Antagonistleri: flutamid, nilutamid ve bikalutamid 3. Gonadorelin (GnRH) Analogları ve Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: (i) Gonadorelin Analogları: Buserelin, goserelin, histrelin, löprorelin, triptorelin; (ii) Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: Degareliks 4. Somatostatin Analogları: Lanreotid, okstreotid
(C) İmmünomodülatörler	Aldeslökin (IL-2) Denilökin diftitoks Lenalidomid ve Talidomid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

7. **Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi alkilleyici bir ajandır?**

A) Klorambusil ✔

B) Gemsitabin

C) 6-Merkaptopürin

D) Paklitaksel

E) Epirubisin

F26 Final 2025–2026 • Soru 7

الإجابة **A** **Klorambusil**

من الدرس 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması **سلايد 33**

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları			İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(A) Sitotoksik İlaçlar			
(1) Alkilleyici İlaçlar			siklofosfamid, ifosfamid, melfalan, klorambusil, busulfan, treosulfan, karmustin, lomustin, bendamustin
(2) Platin Koordinasyon Bileşikleri			sisplatin, karboplatin, oksaliplatin
(3) Antimetabolitler			(a) Folik asit analogları: metotreksat, pemetreksed, raltreksed (b) Pürin analogları ve benzeri inhibitörler: 6-merkaptopürin, pentostatin, fludarabin, klofarabin, nelarabin, kladribin (c) Pirimidin analogları: 5-fluorourasil, azasitidin, gemsitabin, kapesitabin, sitarabin, tegafur (urasilli)
Doğal Ürünler	(4) Mikrotübül İnhibitörleri	Vinka Alkaloidleri	vinkristin sülfat, vinblastin sülfat, vindesin sülfat, vinflunin, vinorelbin
		Taksanlar	paklitaksel, dozetaksel, karbazitaksel,
	(5) Topoizomereaz İnhibitörleri	Topoizomeraz I İnhibitörleri (Kompotesinler)	irinotekan, topotekan
		Topoizomeraz II İnhibitörleri (Epipodofilotoksinler)	etoposid, tenipozid
	(6) Antrasiklin Türevleri ve Diğer Sitotoksik Antibiyotikler		doksorubisin, daunorubisin, bleomisin, daktinomisin, epirubisin, idarubisin, mitoksantron, mitomisin
	(7) Farklı Etki Mekanizmalı İlaçlar		prokrabazin, dakarbazin, hidroksiüre, l-asparaginaz, abirateron asetat, enzalutamid, temozolamid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 33

8. Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi malign melanoma tedavisinde kullanılan bir "CTLA-4 immün kontrol noktası inhibitörü"dür?

A) İpilimumab ✓
B) Trastuzumab
C) Sunitinib
D) Olaparib
E) Rituksimab

F26 Final 2025–2026 • Soru 8

ملحوظة
السؤال ده موجود كمان في درس 4. سلايد 35 هنا بيحط ipilimumab مع مثبطات الـ CTLA-4؛ استخدامه في الميلانوما مكتوب في درس 4.

الإجابة **A İpilimumab**

من الدرس **سلايد 35** Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması



Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(D) Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)	
(1) EGFR (ErB1) İnhibitörleri	erlotinib, setuksimab, panitumumab
(2) HER2/neu (ErB1) İnhibitörleri	trastuzumab, lapatinib*
(3) BCR-ABL TK İnhibitörleri	imatinib, dasatinib, nilotinib, bisutinib, ponatinib
(4) Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) İnhibitörleri	alektinib, brigatinib, seritinib, krizotinib, lorlatinib
(5) Anjiyogenez İnhibitörleri	bevasizumab, sunitinib, sorafenib
(6) BRAF V600E ve V600K İnhibitörleri	binimetinib, kobimetinib, dabrafenib, enkorafenib, trametinib, vemurafenib
(7) Bruton Kinaz İnhibitörleri	ibrutinib, akalabrutinib
(8) Proteazom İnhibitörleri	bortezomib
(9) BCL2 İnhibitörleri	venetoklaks
(10) Programlanmış Ölüm (PD-1) Kontrol Noktası İnhibitörleri	nivolumab, pembrolizumab
(11) CTLA-4 İnhibitörleri	İpilimumab, tremelimumab
(12) PARP İnhibitörleri	olaparib, niraparib, talazoparib
(13) mTOR İnhibitörleri	temsirolimus, everolimus
(14) CD Antijen İnhibitörleri	rituksimab, gemtuzumab, alemtuzumab

lapatinib*: hem ErB1 hem de ErB2 inhibitörüdür.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 35

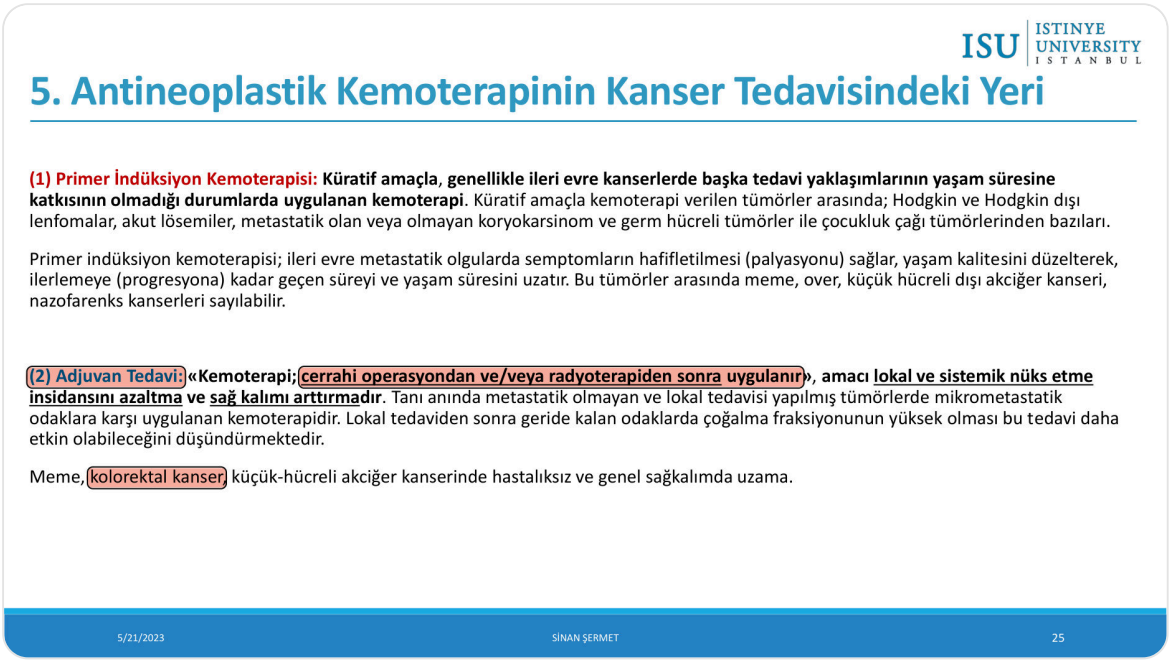
1. **66 yaşında bir erkek hastaya kolorektal kanser tanısı konulmuş ve tümör cerrahisi "sonrası" antineoplastik kemoterapi planlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedavi biçimini en iyi tanımlar?**

A) Adjuvan tedavi ✓
B) Neoadjuvan tedavi
C) Palyatif tedavi
D) Semptomatik tedavi
E) İdame tedavisi

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 1

الإجابة **A** **Adjuvan tedavi**

من الدرس **سلايد 25** 5. Antineoplastik Kemoterapinin Kanser Tedavisindeki Yeri



ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

5. Antineoplastik Kemoterapinin Kanser Tedavisindeki Yeri

(1) Primer İndüksiyon Kemoterapisi: Küratif amaçla, genellikle ileri evre kanserlerde başka tedavi yaklaşımlarının yaşam süresine katkısının olmadığı durumlarda uygulanan kemoterapi. Küratif amaçla kemoterapi verilen tümörler arasında; Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar, akut lösemiler, metastatik olan veya olmayan koryokarsinom ve germ hücreli tümörler ile çocukluk çağı tümörlerinden bazıları.

Primer indüksiyon kemoterapisi; ileri evre metastatik olgularda semptomların hafifletilmesi (palyasyonu) sağlar, yaşam kalitesini düzelterek, ilerlemeye (progresyona) kadar geçen süreyi ve yaşam süresini uzatır. Bu tümörler arasında meme, over, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, nazofarenks kanserleri sayılabilir.

(2) Adjuvan Tedavi: «Kemoterapi; cerrahi operasyondan ve/veya radyoterapiden sonra uygulanır», amacı lokal ve sistemik nüks etme insidansını azaltma ve sağ kalımı arttırmadır. Tanı anında metastatik olmayan ve lokal tedavisi yapılmış tümörlerde mikrometastatik odaklara karşı uygulanan kemoterapidir. Lokal tedaviden sonra geride kalan odaklarda çoğalma fraksiyonunun yüksek olması bu tedavi daha etkin olabileceğini düşündürmektedir.

Meme, kolorektal kanser, küçük-hücreli akciğer kanserinde hastalıksız ve genel sağkalımda uzama.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 25

5. **Aşağıdakilerden hangisi antianjiogenik etkinliği de olan çoklu kinaz hedefli bir antineoplastik ilaç olup renal hücreli karsinom ve hepatoselüler karsinom tedavisinde kullanılır?**

A) Sorafenib ✓
B) Binimetinib
C) Bortezomib
D) İmatinib
E) Setuksimab

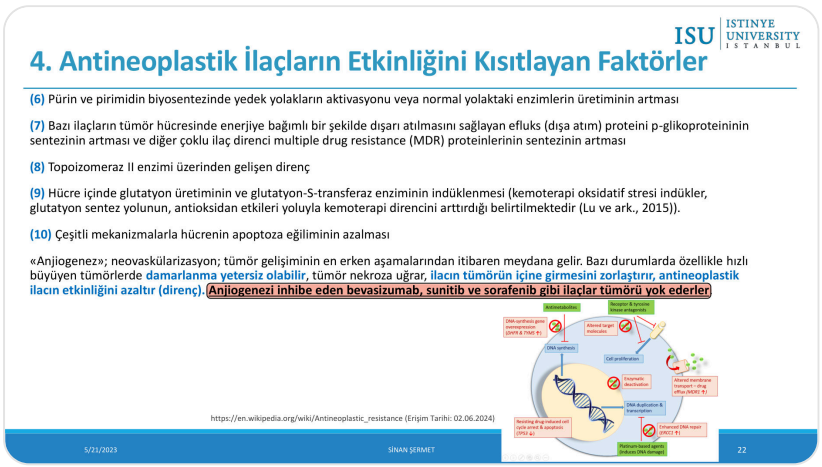
K26 Kurul 2025–2026 • Soru 5

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 4. سلايد 35 و22 هنا بيقولوا إن sorafenib من مثبطات تكوين الأوعية (anjiyogenez)، وده الاختيار الوحيد كده. إنه متعدد الكينازات وبيتستخدم في سرطان الكلى والكبد مكتوب في درس 4.

الإجابة **A Sorafenib**

من الدرس **سلايد 22** 4. Antineoplastik İlaçların Etkinliğini Kısıtlayan Fakt...



من الدرس **سلايد 35** Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması



52

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bir androjen reseptör antagonisti olup, prostat kanseri tedavisinde kullanılır?

- ✓ **A)** Flutamid ✓
- **B)** Mesterolon
- **C)** Oksimetolon
- **D)** Finasterid
- **E)** Siproheptadin

K6-25 Kurul 2024–2025 • Soru 52

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 5. سلايد 34 هنا بيقول إن flutamid مضاد لمستقبل الأندروجين وبيتستخدم في سرطان البروستاتا.

الإجابة **A** Flutamid

من الدرس **سلايد 34** 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(B) Hormonlar ve Hormon Antagonistleri	Glukokortikoidler (kortikosteroidler), östrojenler (dietilstilbesterol, etinilöstradiol), progestojenler (projestinler) (medroksiprogesteron asetat, mejestrol asetat, noretisteron) 1. Meme Kanserinde Kullanılanlar (Östrojen Antagonistleri): Aromataz İnhibitörleri: anastrozol, eksemestan, fulvestrant, letrozol, Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifene, raloksifen 2. Prostat Kanserinde Kullanılanlar (Anti-Androjenler): Androjen Reseptör Antagonistleri: flutamid, nilutamid ve bikalutamid 3. Gonadorelin (GnRH) Analogları ve Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: (i) Gonadorelin Analogları: Buserelin, goserelin, histrelin, löprorelin, triptorelin; (ii) Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: Degareliks 4. Somatostatin Analogları: Lanreotid, okstreotid
(C) İmmünomodülatörler	Aldeslökin (IL-2) Denilökin diftitoks Lenalidomid ve Talidomid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

ملاحظات

16	Tıbbi Farmakoloji SİNAN ŞERMET	Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi bir programlanmış ölüm (PD-1) noktası inhibitörüdür?	12677

✓ **A)** Pembrolizumab ✓

B) İpilimumab

C) Vemurafenib

D) Venetoklaks

E) Binimetinib

F25 Final 2024–2025 • Soru 16

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 4. سلايد 35 هنا (تصنيف الأدوية) بيحط pembrolizumab مع مثبطات الـ PD-1.

الإجابة **A** **Pembrolizumab**

من الدرس **سلايد 35** Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(D) Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)	
(1) EGFR (ErB1) İnhibitörleri	erlotinib, setuksimab, panitumumab
(2) HER2/neu (ErB1) İnhibitörleri	trastuzumab, lapatinib*
(3) BCR-ABL TK İnhibitörleri	imatinib, dasatinib, nilotinib, bisutinib, ponatinib
(4) Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) İnhibitörleri	alektinib, brigatinib, seritinib, krizotinib, lorlatinib
(5) Anjiyogenez İnhibitörleri	bevasizumab, sunitinib, sorafenib
(6) BRAF V600E ve V600K İnhibitörleri	binimetinib, kobimetinib, dabrafenib, enkorafenib, trametinib, vemurafenib
(7) Bruton Kinaz İnhibitörleri	ibrutinib, akalabrutinib
(8) Proteazom İnhibitörleri	bortezomib
(9) BCL2 İnhibitörleri	venetoklaks
(10) Programlanmış Ölüm (PD-1) Kontrol Noktası İnhibitörleri	nivolumab, pembrolizumab
(11) CTLA-4 İnhibitörleri	ipilimumab, tremelimumab
(12) PARP İnhibitörleri	olaparib, niraparib, talazoparib
(13) mTOR İnhibitörleri	temsirolimus, everolimus
(14) CD Antijen İnhibitörleri	rituksimab, gemtuzumab, alemtuzumab

lapatinib*: hem ErB1 hem de ErB2 inhibitörüdür.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 35

ملاحظات

69. **Östorjen reseptörü pozitif (ÖR (+) veya ER (+) olarak da ifade edilir) meme kanseri teşhisi konulan 60 yaşında bir kadın hastaya antineoplastik kemoterapi başlanması planlanmaktadır. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin seçilmesi hastanın tedavisi için en uygundur?**

A) Tamoksifen ✓
B) Bikalutamid
C) Prednizolon
D) Lantreotid
E) Mitotan

K25 Kurul 2024–2025 • Soru 69

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 5. سلايد 34 هنا بيحط tamoksifen تحت «أدوية سرطان الثدي» (مضادات الإستروجين).

الإجابة **A Tamoksifen**

من الدرس **سلايد 34** 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(B) Hormonlar ve Hormon Antagonistleri	Glukokortikoidler (kortikosteroidler), östrojenler (dietilstilbesterol, etinilöstradiol), progestojenler (projestinler) (medroksiprogesteron asetat, mejestrol asetat, noretisteron) 1. Meme Kanserinde Kullanılanlar (Östrojen Antagonistleri): Aromataz İnhibitörleri: anastrozol, eksemestan, fulvestrant, letrozol, Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen toremifene, raloksifen 2. Prostat Kanserinde Kullanılanlar (Anti-Androjenler): Androjen Reseptör Antagonistleri: flutamid, nilutamid ve bikalutamid 3. Gonadorelin (GnRH) Analogları ve Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: (i) Gonadorelin Analogları: Buserelin, goserelin, histrelin, löprorelin, triptorelin; (ii) Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: Degareliks 4. Somatostatin Analogları: Lanreotid, okstreotid
(C) İmmünomodülatörler	Aldeslökin (IL-2) Denilökin diftitoks Lenalidomid ve Talidomid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

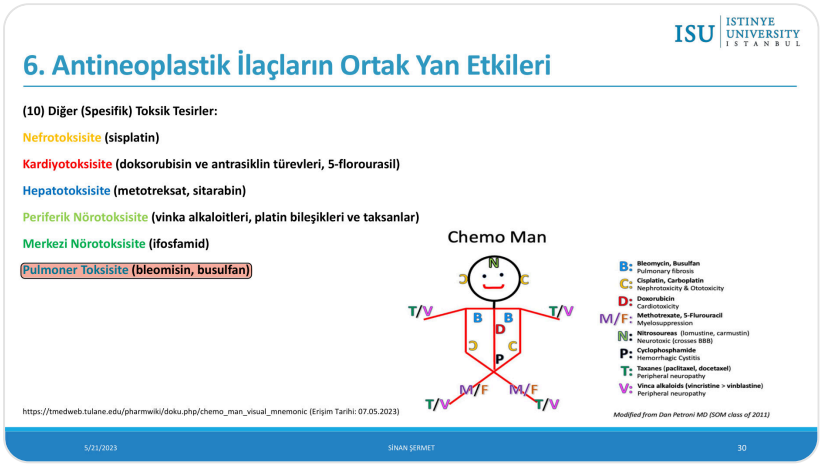
70. **Hodgkin lenfoma tanısı alan 35 yaşındaki hastaya ABVD standart tedavisi başlanıyor. Birkaç kür sonunda hastada daha önce bu semptomlar olmamakla birlikte kronik öksürük ve nefes darlığı semptomları gelişiyor ve yapılan muayene ve testlerde hastada "pnömonitis" geliştiği belirleniyor. Hastaya uygulanan kombinasyon tedavisindeki hangi ilacın bu yan etkiyi oluşturma potansiyeli en fazladır?**

A) Bleomisin ✓
B) Alemtuzumab
C) Vinkristin
D) Dakarbazin
E) Doksorubisin

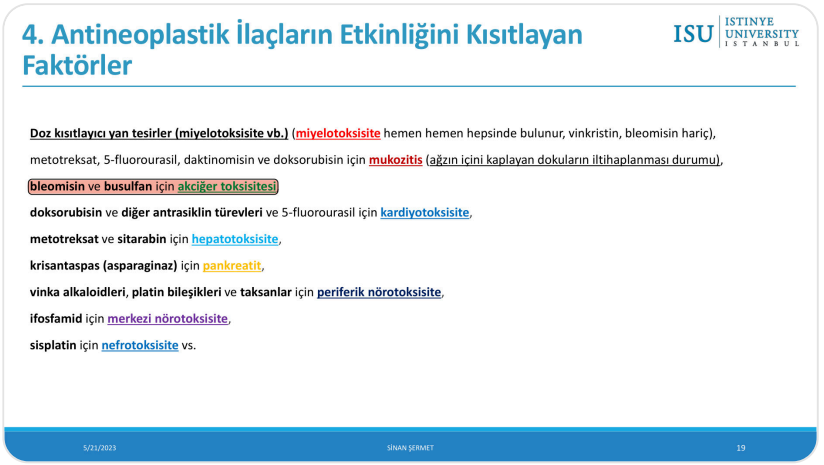
K25 Kurul 2024–2025 · Soru 70

A **Bleomisin** الإجابة

من الدرس **سلايد 30** 6. Antineoplastik İlaçların Ortak Yan Etkileri



من الدرس **سلايد 19** 4. Antineoplastik İlaçların Etkinliğini Kısıtlayan Fakt...



57. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir GnRH analoğudur?

A) Löprolid ✔
B) Dutasterid
C) Siproteron asetat
D) Spironolakton
E) Mesterolon

K6-24 Kurul 2023–2024 · Soru 57

ملحوظة
السؤال ده موجود كمان في درس 5. سلايد 34 هنا بيعدّ مشابهات الـ GnRH. ومنهم löprorelin (هو نفسه / Löprolid leuprolide).

الإجابة **A** Löprolid

من الدرس **سلايد 34** 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(B) Hormonlar ve Hormon Antagonistleri	Glukokortikoidler (kortikosteroidler), östrojenler (dietilstilbesterol, etinilöstradiol), progestojenler (projestinler) (medroksiprogesteron asetat, mejestrol asetat, noretisteron) 1. Meme Kanserinde Kullanılanlar (Östrojen Antagonistleri): Aromataz İnhibitörleri: anastrozol, eksemestan, fulvestrant, letrozol, Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifene, raloksifen 2. Prostat Kanserinde Kullanılanlar (Anti-Androjenler): Androjen Reseptör Antagonistleri: flutamid, nilutamid ve bikalutamid 3. Gonadorelin (GnRH) Analogları ve Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: (i) Gonadorelin Analogları: Buserelin, goserelin, histrelin, löprorelin, triptorelin (ii) Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: Degareliks 4. Somatostatin Analogları: Lanreotid, okstreotid
(C) İmmünomodülatörler	Aldeslökin (IL-2) Denilökin diftitoks Lenalidomid ve Talidomid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

ملاحظات

81. **Aşağıdaki "akıllı ilaç – etki mekanizması" çiftlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?**

A) Nivolumab - Anti-CD20 monoklonal antikoru ✓
B) Bevasizumab - VEGF inhibitörü
C) Setuksimab - EGFR inhibitörü
D) İmatinib - BCR-ABL TK inhibitörü
E) Venetoklaks - BCL2 inhibitörü

K24 Kurul 2023–2024 • Soru 81

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 4. سلايد 35 هنا بيقول إن nivolumab مثبط PD-1 (مش anti-CD20)، وباقي الأزواج صح زي ما هي في جدول التصنيف.

الإجابة

A **Nivolumab - Anti-CD20 monoklonal antikoru**

من الدرس **سلايد 35** Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(D) Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)	
(1) EGFR (ErB1) İnhibitörleri	erlotinib, setuksimab panitumumab
(2) HER2/neu (ErB1) İnhibitörleri	trastuzumab, lapatinib*
(3) BCR-ABL TK İnhibitörleri	imatinib dasatinib, nilotinib, bisutinib, ponatinib
(4) Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) İnhibitörleri	alektinib, brigatinib, seritinib, krizotinib, lorlatinib
(5) Anjiyogenez İnhibitörleri	bevasizumab sunitinib, sorafenib
(6) BRAF V600E ve V600K İnhibitörleri	binimetinib, kobimetinib, dabrafenib, enkorafenib, trametinib, vemurafenib
(7) Bruton Kinaz İnhibitörleri	ibrutinib, akalabrutinib
(8) Proteazom İnhibitörleri	bortezomib
(9) BCL2 İnhibitörleri	venetoklaks
(10) Programlanmış Ölüm (PD-1) Kontrol Noktası İnhibitörleri	nivolumab, pembrolizumab
(11) CTLA-4 İnhibitörleri	ipilimumab, tremelimumab
(12) PARP İnhibitörleri	olaparib, niraparib, talazoparib
(13) mTOR İnhibitörleri	temsirolimus, everolimus
(14) CD Antijen İnhibitörleri	rituksimab, gemtuzumab, alemtuzumab

lapatinib*: hem ErB1 hem de ErB2 inhibitörüdür.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 35

89- Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi Selektif Östrojen Reseptörü (ÖR) Modülatörüdür (SERM), hem östrojenik hem de antiöstrojenik aktiviteye sahiptir ve ÖR(+) meme kanserinin tedavisinde kullanılır?

a) Siklofosfamid
b) Tamoksifen
c) Flutamid
d) Löprolid
e) Vinkristin

K23 Kurul 2022–2023 • Soru 89

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 5. سلايد 34 هنا بيقول إن tamoksifen من الـ SERM اللي بتستخدم في سرطان الثدي.

الإجابة **B** **Tamoksifen**

من الدرس **سلايد 34** 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(B) Hormonlar ve Hormon Antagonistleri	Glukokortikoidler (kortikosteroidler), östrojenler (dietilstilbesterol, etinilöstradiol), progestojenler (projestinler) (medroksiprogesteron asetat, mejestrol asetat, noretisteron) 1. Meme Kanserinde Kullanılanlar (Östrojen Antagonistleri): Aromataz İnhibitörleri: anastrozol, eksemestan, fulvestrant, letrozol, Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen toremifene, raloksifen 2. Prostat Kanserinde Kullanılanlar (Anti-Androjenler): Androjen Reseptör Antagonistleri: flutamid, nilutamid ve bikalutamid 3. Gonadorelin (GnRH) Analogları ve Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: (i) Gonadorelin Analogları: Buserelin, goserelin, histrelin, löprorelin, triptorelin; (ii) Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: Degareliks 4. Somatostatin Analogları: Lanreotid, okstreotid
(C) İmmünomodülatörler	Aldeslökin (IL-2) Denilökin diftitoks Lenalidomid ve Talidomid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

91- Aşağıdaki hedeflerden hangisi nivolumab tarafından inhibe edilir?

a) BCL2
b) BCR-ABL tirozin kinaz
c) Programlanmış Ölüm-1 (PD-1) Kontrol Kapısı
d) mTOR
e) VEGF

K23 Kurul 2022–2023 • Soru 91

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 4. سلايد 35 هنا (تصنيف الأدوية) بيحط nivolumab مع مثبطات الـ PD-1.

الإجابة

C **Programlanmış Ölüm-1 (PD-1) Kontrol Kapısı**

من الدرس Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması **سلايد 35**

Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(D) Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)	
(1) EGFR (ErB1) İnhibitörleri	erlotinib, setuksimab, panitumumab
(2) HER2/neu (ErB1) İnhibitörleri	trastuzumab, lapatinib*
(3) BCR-ABL TK İnhibitörleri	imatinib, dasatinib, nilotinib, bisutinib, ponatinib
(4) Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) İnhibitörleri	alektinib, brigatinib, seritinib, krizotinib, lorlatinib
(5) Anjiyogenez İnhibitörleri	bevasizumab, sunitinib, sorafenib
(6) BRAF V600E ve V600K İnhibitörleri	binimetinib, kobimetinib, dabrafenib, enkorafenib, trametinib, vemurafenib
(7) Bruton Kinaz İnhibitörleri	ibrutinib, akalabrutinib
(8) Proteazom İnhibitörleri	bortezomib
(9) BCL2 İnhibitörleri	venetoklaks
(10) Programlanmış Ölüm (PD-1) Kontrol Noktası İnhibitörleri	nivolumab, pembrolizumab
(11) CTLA-4 İnhibitörleri	ipilimumab, tremelimumab
(12) PARP İnhibitörleri	olaparib, niraparib, talazoparib
(13) mTOR İnhibitörleri	temsirolimus, everolimus
(14) CD Antijen İnhibitörleri	rituksimab, gemtuzumab, alemtuzumab

lapatinib*: hem ErB1 hem de ErB2 inhibitörüdür.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 35

ملاحظات

56- Semptomları ilerlemiş prostat kanseri olan 71 yaşında bir erkek hastaya, gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) reseptörlerinin yarışmalı antagonisti bir ilaçla tedaviye başlanmışsa, bu hasta büyük olasılıkla aşağıdaki ilaçlardan hangisini almaktadır?

a) Degareliks
b) Löprolid
c) Kabergolin
d) Pegvisomant
e) Mekasermin

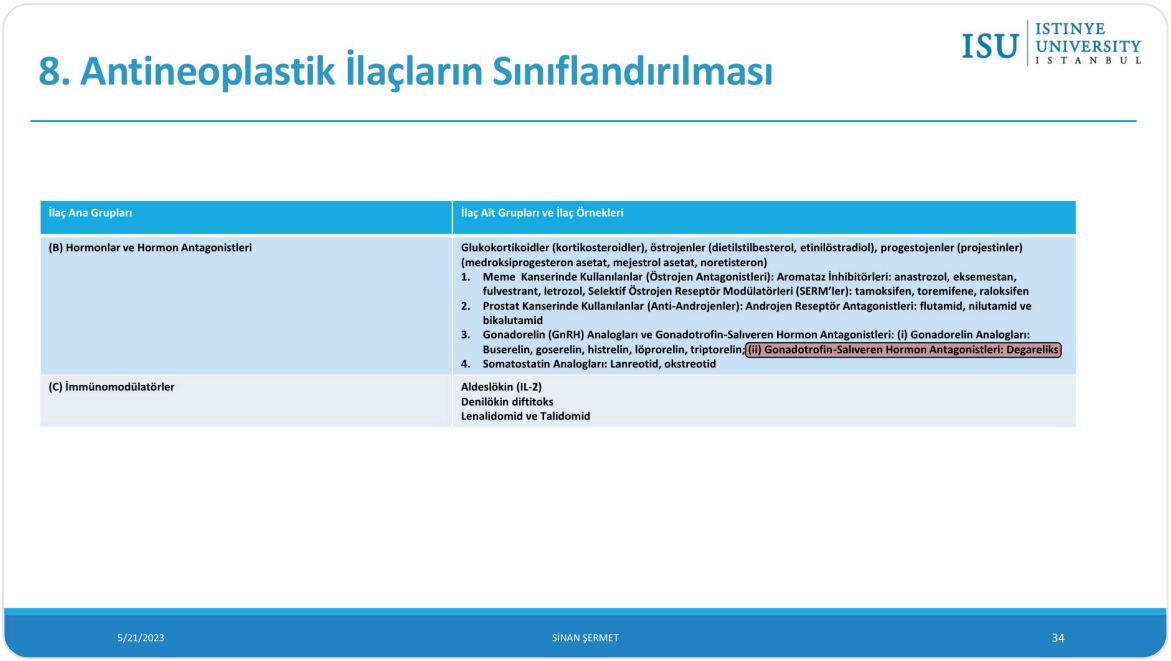
K6-22 Kurul 2021–2022 · Soru 56

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 5. سلايد 34 هنا بيقول إن Degareliks هو مضاد مستقبل الـ GnRH.

الإجابة **A** Degareliks

من الدرس 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması **سلايد 34**



8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(B) Hormonlar ve Hormon Antagonistleri	Glukokortikoidler (kortikosteroidler), östrojenler (dietilstilbesterol, etinilöstradiol), progestojenler (projestinler) (medroksiprogesteron asetat, mejestrol asetat, noretisteron) 1. Meme Kanserinde Kullanılanlar (Östrojen Antagonistleri): Aromataz İnhibitörleri: anastrozol, eksemestan, fulvestrant, letrozol, Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifene, raloksifen 2. Prostat Kanserinde Kullanılanlar (Anti-Androjenler): Androjen Reseptör Antagonistleri: flutamid, nilutamid ve bikalutamid 3. Gonadorelin (GnRH) Analogları ve Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: (i) Gonadorelin Analogları: Buserelin, goserelin, histrelin, löprorelin, triptorelin; (ii) Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: Degareliks 4. Somatostatin Analogları: Lanreotid, okstreotid
(C) İmmünomodülatörler	Aldeslökin (IL-2) Denilökin diftitoks Lenalidomid ve Talidomid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

ملاحظات

Soru 52 1 puan

Elli yaşında pozitif mamogramısı olan kadın hastada, küçük bir karsinom çıkarılarak inceleniyor. Estrojen ve projesteron reseptör pozitif ise aşağıdaki ilaçlardan hangisini alabilir?

En az bir doğru yanıt seçin

- A Klomifen
- B Löprolid
- C Tamoksifen ✓ *Doğru yanıt*
- D Etinil estradiol
- E Mitotan

K6-21 Kurul 2020–2021 • Soru 52

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 5. سلايد 34 هنا بيحط tamoksifen تحت «أدوية سرطان الثدي» (مضادات الإستروجين).

الإجابة **C Tamoksifen**

من الدرس **سلايد 34** 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(B) Hormonlar ve Hormon Antagonistleri	Glukokortikoidler (kortikosteroidler), östrojenler (dietilstilbesterol, etinilöstradiol), progestojenler (projestinler) (medroksiprogesteron asetat, mejestrol asetat, noretisteron) 1. Meme Kanserinde Kullanılanlar (Östrojen Antagonistleri): Aromataz İnhibitörleri: anastrozol, eksemestan, fulvestrant, letrozol, Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen toremifene, raloksifen 2. Prostat Kanserinde Kullanılanlar (Anti-Androjenler): Androjen Reseptör Antagonistleri: flutamid, nilutamid ve bikalutamid 3. Gonadorelin (GnRH) Analogları ve Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: (i) Gonadorelin Analogları: Buserelin, goserelin, histrelin, löprorelin, triptorelin; (ii) Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: Degareliks 4. Somatostatin Analogları: Lanreotid, okstreotid
(C) İmmünomodülatörler	Aldeslökin (IL-2) Denilökin diftitoks Lenalidomid ve Talidomid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

56 - İnsan solid kanserleri, tümör büyümesi ve gerilemesi sürecinde Gompertzian modelini izler. Kolorektal kanser gibi bir solid tümörde, aşağıdaki durumlardan hangisi kanser kemoterapötikleri ile daha yüksek oranda hücre öldürülmesini **desteklemez**?

a) Hücre siklusuna özgül olmayan ilaçların kullanımı
b) DNA'da yüksek hasara yol açan ilaçların kullanımı
c) Hücrede daha uzun süre kalan ilaçların kullanımı
d) Tümörün maksimum boyutun yaklaşık üçte birine erişmiş olması
e) Düşük büyüme fraksiyonuna sahip büyük tümör kütlesi (Doğru)

K21 Kurul 2020–2021 · Soru 56

الإجابة

E Düşük büyüme fraksiyonuna sahip büyük tümör kütlesi

من الدرس 4. Antineoplastik İlaçların Etkinliğini Kısıtlayan Faktörler **سلايد 17**

4. Antineoplastik İlaçların Etkinliğini Kısıtlayan Faktörler

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

A.3. Tümörün proliferasyon hızı: **Hızlı çoğalan tümörler antineoplastik ilaçların çoğuna** özellikle de antimetabolit ve sitotoksik antibiyotiklere **daha duyarlıdırlar**

Tümör büyüdükçe proliferasyon hızı azalır, neovaskülarizasyon ile birlikte metastaz olasılığı artar.

İki tedavi yaklaşımının temelleri:

(i) Bir tümörün lokal tedavisinin ardından mikrometastatik hastalığa yönelik «adjuvant kemoterapi» uygulanması

(ii) Tümör kitlesinin cerrahi olarak azaltılması

Her iki durumda da tedavi sonunda kalan (rezidüel) mikroskopik veya makroskobik tümörde çoğalma fraksiyonu artacak ve kemoterapötiklerin etkinliği artacaktır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 17

83 - Aşağıdaki antiandrojenlerden hangisi androjen reseptör antagonistidir ve prostat kanserinin tedavisinde kullanılır?

a) Flutamid (Doğru) ✓
b) Abirateron asetat
c) Finasterid
d) Goserelin
e) Löprolid

F20 Final 2019–2020 • Soru 83

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 5. سلايد 34 هنا بيقول إن flutamid مضاد لمستقبل الأندروجين وبيتستخدم في سرطان البروستاتا.

الإجابة **A** **Flutamid**

من الدرس 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması **سلايد 34**

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(B) Hormonlar ve Hormon Antagonistleri	Glukokortikoidler (kortikosteroidler), östrojenler (dietilstilbesterol, etinilöstradiol), progestojenler (projestinler) (medroksiprogesteron asetat, mejestrol asetat, noretisteron) 1. Meme Kanserinde Kullanılanlar (Östrojen Antagonistleri): Aromataz İnhibitörleri: anastrozol, eksemestan, fulvestrant, letrozol, Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifene, raloksifen 2. Prostat Kanserinde Kullanılanlar (Anti-Androjenler): Androjen Reseptör Antagonistleri: flutamid, nilutamid ve bikalutamid 3. Gonadorelin (GnRH) Analogları ve Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: (i) Gonadorelin Analogları: Buserelin, goserelin, histrelin, löprorelin, triptorelin; (ii) Gonadotrofin-Salıveren Hormon Antagonistleri: Degareliks 4. Somatostatin Analogları: Lanreotid, okstreotid
(C) İmmünomodülatörler	Aldeslökin (IL-2) Denilökin diftitoks Lenalidomid ve Talidomid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

آخر الملف

للمراجعة

15 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

11. 40 yaşında bir erkek hastaya kemik iliği nakli yapılacak olup, nakli kolaylaştırmak için kemik iliği mobilizasyonuna yönelik ilaç tedavisi planlanıyor. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılabilir?

A) Lenograstim
B) Darbepoetin alfa
C) Oprelvekin
D) Romiplostim
E) Lusutrombopag

F26 Final 2025–2026 · Soru 11

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده أساساً من درس 10. سلايد 20 هنا بيذكر الـlenograstim (G-CSF) وزرع الخلايا الجذعية مع الكيماوي عالي الجرعة، بس مش بيقول إنه بيتستخدم لتحريك خلايا النخاع (mobilization) قبل الزرع. الإجابة في درس 10.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

3. **Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi başlıca "dihidrofolat redüktaz" ve "timidilat sentaz" enzimlerini inhibe ederek etki gösteren ve çok çeşitli hematolojik ve solid tümörlerin tedavisinde kullanılan bir antimetabolit ilaçtır?**

A) Metotreksat ✓
B) 6-Merkaptopürin
C) Vinblastin
D) Paklitaksel
E) Etoposid

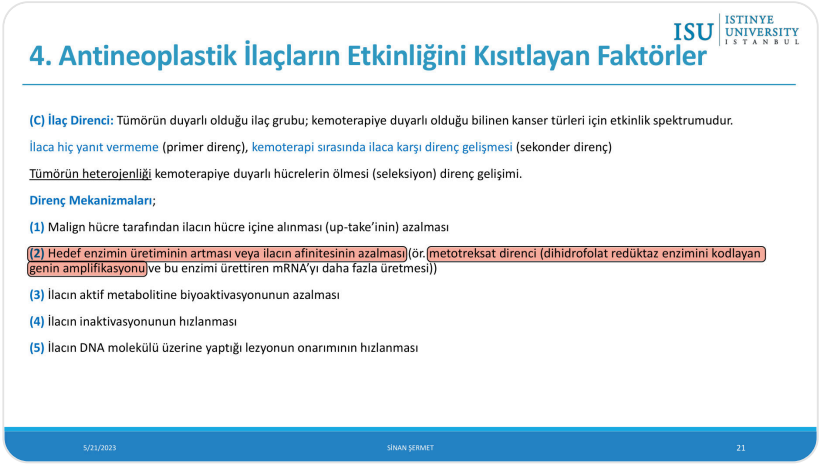
K26 Kurul 2025–2026 • Soru 3

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده أساساً من درس 3 (Antimetabolitler). بس سلايد 21 هنا بيقول إن مقاومة الميثوتريكسات بتيجي من زيادة إنزيمه الهدف dihidrofolat redüktaz، وسلايد 33 بيحطه مع مشابهات حمض الفوليك. حكاية الـ timidilat sentaz مكتوبة في درس 3.

الإجابة **A** **Metotreksat**

من الدرس **سلايد 21** 4. Antineoplastik İlaçların Etkinliğini Kısıtlayan Fakt...



ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

4. Antineoplastik İlaçların Etkinliğini Kısıtlayan Faktörler

(C) İlaç Direnci: Tümörün duyarlı olduğu ilaç grubu; kemoterapiye duyarlı olduğu bilinen kanser türleri için etkinlik spektrumudur.

İlaca hiç yanıt vermeme (primer direnç), kemoterapi sırasında ilaca karşı direnç gelişmesi (sekonder direnç)

Tümörün heterojenliği kemoterapiye duyarlı hücrelerin ölmesi (seleksiyon) direnç gelişimi.

Direnç Mekanizmaları;

(1) Malign hücre tarafından ilacın hücre içine alınması (up-take'inin) azalması

(2) Hedef enzimin üretiminin artması veya ilacın afinitesinin azalması (ör. metotreksat direnci (dihidrofolat redüktaz enzimini kodlayan genin amplifikasyonu ve bu enzimi ürettiren mRNA'yı daha fazla üretmesi))

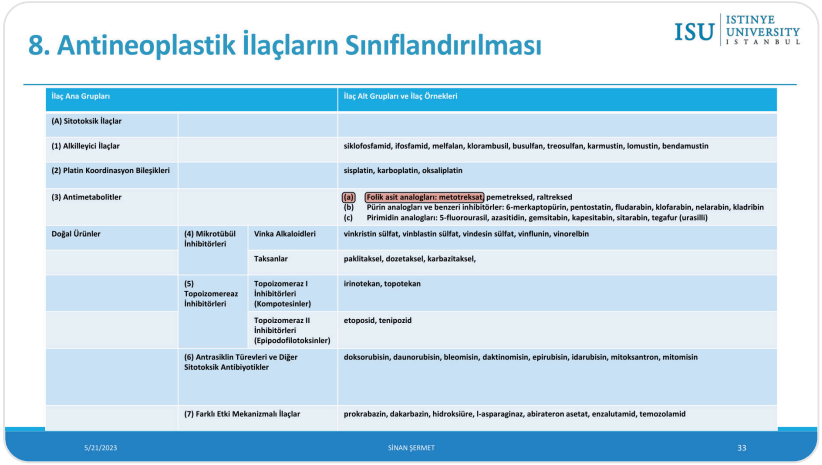
(3) İlacın aktif metabolitine biyoaktivasyonunun azalması

(4) İlacın inaktivasyonunun hızlanması

(5) İlacın DNA molekülü üzerine yaptığı lezyonun onarımının hızlanması

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 21

من الدرس **سلايد 33** 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması



ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

İlaç Ana Grupları			İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(A) Sitotoksik İlaçlar			
(1) Alkilleyici İlaçlar			siklofosfamid, ifosfamid, melfalan, klorambusil, busulfan, treosulfan, karmustin, lomustin, bendamustin
(2) Platin Koordinasyon Bileşikleri			sisplatin, karboplatin, oksaliplatin
(3) Antimetabolitler			(a) Folik asit analogları: metotreksat, pemetreksed, raltreksed (b) Pürin analogları ve benzeri inhibitörler: 6-merkaptopürin, pentostatin, fludarabin, klofarabin, nelarabin, kladribin (c) Pirimidin analogları: 5-fluorourasil, azasitidin, gemsitabin, kapesitabin, sitarabin, tegafur (urasilli)
Doğal Ürünler	(4) Mikrotübül İnhibitörleri	Vinka Alkaloidleri	vinkristin sülfat, vinblastin sülfat, vindesin sülfat, vinflunin, vinorelbin
		Taksanlar	paklitaksel, dozetaksel, karbazitaksel,
	(5) Topoizomereaz İnhibitörleri	Topoizomeraz I İnhibitörleri (Kompotesinler)	irinotekan, topotekan
		Topoizomeraz II İnhibitörleri (Epipodofilotoksinler)	etoposid, tenipozid
	(6) Antrasiklin Türevleri ve Diğer Sitotoksik Antibiyotikler		doksorubisin, daunorubisin, bleomisin, daktinomisin, epirubisin, idarubisin, mitoksantron, mitomisin
	(7) Farklı Etki Mekanizmalı İlaçlar		prokrabazin, dakarbazin, hidroksiüre, l-asparaginaz, abirateron asetat, enzalutamid, temozolamid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 33

12. **50 yaşında siklofosfamid tedavisi alan bir erkek hastaya kemoterapiye bağlı miyelotoksisite sonucu gelişebilecek şiddetli nötropeni tedavisi için ilaç tedavisi başlanması planlanıyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu durumun tedavisinde kullanılabilir?**

A) Filgrastim ✓
B) Oprelvekin
C) Eltrompobag
D) Romiplostim
E) Darbepoetin alfa

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 12

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده أساساً من درس 10 (Hematopoetik Büyüme Faktörleri)، وإسلام كاتب جنبه 10. بس سلايد 27 في الدرس ده بيقول إن لما الكيماوي يثبّط نخاع العظم بنستخدم filgrastim عشان نقصّر مدة النوتروبينيا.

الإجابة **A Filgrastim**

من الدرس **سلايد 27** 6. Antineoplastik İlaçların Ortak Yan Etkileri

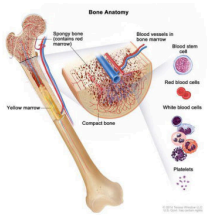
ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

6. Antineoplastik İlaçların Ortak Yan Etkileri

(1) Miyelotoksisite: Kemik İliğinin Baskılanması: Antineoplastik ilaçlar kemik iliğinde lökosit, eritrosit ve trombosit oluşturan hücreler üzerinde toksisite gösterirler. Bleomisin ve vinkristin bu açıdan toksisiteleri düşük ilaçlardır.

Lökosit 6 saat, Eritrosit 120 gün, Trombosit 5 gün yarılanma ömrüne sahiptir. Bu nedenle antineoplastik tedavi süresince lökopeni (nötropeni) çok belirgin derecede ve erken görülür.

Hastalarda gözlenen lökopeni derecesi bireysel farklılıklar gösterdiğinden, tedavi süresince hastaların kan hücresi sayıları izlenmelidir. Lökosit sayısı 1000/mm³'ün altına düştüğünde ciddi sistemik enfeksiyon riski ortaya çıkar, tedaviye uygun bir antimikrobik ilaç eklenmelidir. Trombosit sayısı 40.000/mm³'ün altına düşmesi durumunda ise ciddi kanama riski ortaya çıkmaktadır. İlaçların kemik iliğini baskılama dereceleri farklıdır. Döneme özgü ilaçlar; hızlı gelişen ve hızlı düzelen nötropeni yaparlar (metotreksat, vinblastin, pürin ve pirimidin antimetabolitleri), döneme özgü olmayan ilaçlar ise; genellikle daha yavaş gelişen, uzun süren ve geç düzelen kemik iliği baskılaması yaparlar (ör. nitrozüreler, busulfan ve mitomisin).



https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/bone-marrow Erişim Tarihi: 18.10.2025)

Kemik iliğinin baskılanması antineoplastik ilaçlarla tedavide ilaca bağlı en önemli morbidite ve mortalite sebebidir. Ayrıca ilaçların bu etkisi onların dozlarını kısıtlayan en önemli etkendir.

Kemoterapide ciddi toksisite meydana geldiğinde ilaç dozlarının azaltılması gerekebilir. Kemik iliği baskılanması durumunda nötropeniye yönelik derinlik ve süreyi kısaltmak için hematopoietik büyüme faktörleri (filgrastim lenograstim, pegfilgrastim gibi) kullanılabilir.

Belli aralıklarla ilaç uygulaması ile bir önceki dozun oluşturduğu lökopeni tablosunun düzelmesi sağlanır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 27

16. **Kemoterapiye bağlı gelişen ciddi lökopenisi olan bir hastada, kemik iliğinin nötrofil üretimini hızlandırmak amacıyla aşağıdaki ajanlardan hangisi tercih edilir?**

A) G-CSF ✓
B) GM-CSF
C) Faktör VIII
D) EPO
E) IL-2

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 16

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من درس 10 (مكتوب تحته Kaynak: Goodman & Gilman)، بس سلايد 20 في الدرس ده بيقول إن filgrastim (G-CSF) بيتدّي ضد سُمّية النخاع عشان يمنع النوتروبينيا.

الإجابة **A G-CSF**

من الدرس **سلايد 20** 4. Antineoplastik İlaçların Etkinliğini Kısıtlayan Faktörler

4. Antineoplastik İlaçların Etkinliğini Kısıtlayan Faktörler

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Antineoplastik ilaçların doz kısıtlayıcı yan tesirlerini azaltarak yüksek doz kemoterapi uygulamak için;

(1) İlaçla birlikte antidot verilmesi (**yüksek doz metotreksat ile birlikte folinik asit verilmesi**)

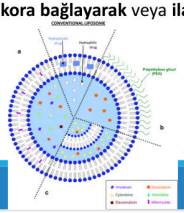
(2) İlacın tümörün yerleştiği bölgeye **lokal olarak** yüksek doz verilmesi (**karaciğer tümörlerinde hepatik arter perfüzyonu, intralezyonel ilaç uygulanması vb.**)

(3) Hematopoetik büyüme faktörleri: Miyelotoksisiteye karşı **filgrastim** (granülosit koloni stimüle edici faktör (GCSF)) **lenograstim** (pegillenmiş metionil G-CSF) **uygulanması** (**nötropeni oluşmasını engellemek için** protokol sonrası uygulama)

(4) Kök hücre nakli: Otolog kök hücre nakli ile yüksek doz kemoterapinin miyelotoksik yan tesirlerini en aza indirmek hedeflenir (otolog kök hücre nakli kemoterapi sonrası hasarlı kemik iliğinin yerini almasına yardımcı olur). Allojenik kök hücre nakli ise immünoterapi amaçlı kullanılır (hastalıklı veya hasarlı kemik iliğini değiştirmek için bir donörden alınan sağlıklı «kan kök hücrelerini» kullanır).

(5) Hedefe yönelik ilaç uygulama sistemleri: Antineoplastik ilacı özgül antikora bağlayarak veya **ilaç çözeltisini yalın veya özgül antikor bağlanmış lipozomlar içine hapsederek hedefe yönlendirme**

(6) Antineoplastik ilaçların daha az toksik analoglarının bulunması, keşfi.



Sousa vd., 2018

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 20

19. Kemoterapiye bağlı emezis tedavisinde kullanılan 5HT3 agonisti ilacı işaretleyiniz.

A) Ondansetron ✓
B) Ketanserin
C) Buspiron
D) Metoklopramid
E) Sumatriptan

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 19

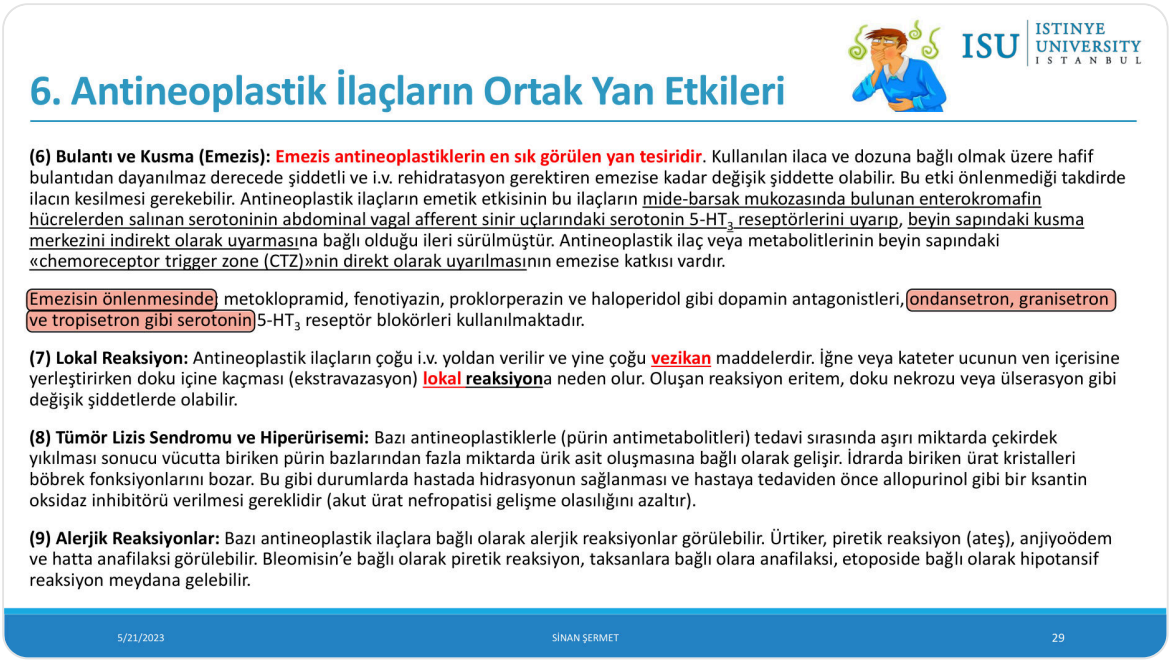
اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من درس 6 (Antiemetik ajanlar). خلي بالك: السؤال كاتب «5HT3 agonisti» بس الصح إن ondansetron بيقفل (blokör) مستقبلات 5-HT3، زي ما سلايد 29 في الدرس ده بيقول.

الإجابة **A Ondansetron**

من الدرس **سلايد 29** 6. Antineoplastik İlaçların Ortak Yan Etkileri



6. Antineoplastik İlaçların Ortak Yan Etkileri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

(6) Bulantı ve Kusma (Emezis): **Emezis antineoplastiklerin en sık görülen yan tesiridir**. Kullanılan ilaca ve dozuna bağlı olmak üzere hafif bulantıdan dayanılmaz derecede şiddetli ve i.v. rehidratasyon gerektiren emezise kadar değişik şiddette olabilir. Bu etki önlenmediği takdirde ilacın kesilmesi gerekebilir. Antineoplastik ilaçların emetik etkisinin bu ilaçların mide-barsak mukozasında bulunan enterokromafin hücrelerden salınan serotoninin abdominal vagal afferent sinir uçlarındaki serotonin 5-HT_3 reseptörlerini uyarıp, beyin sapındaki kusma merkezini indirekt olarak uyarmasına bağlı olduğu ileri sürülmüştür. Antineoplastik ilaç veya metabolitlerinin beyin sapındaki «chemoreceptor trigger zone (CTZ)»nin direkt olarak uyarılmasının emezise katkısı vardır.

Emezisin önlenmesinde metoklopramid, fenotiyazin, proklorperazin ve haloperidol gibi dopamin antagonistleri, ondansetron, granisetron ve tropisetron gibi serotonin 5-HT_3 reseptör blokörleri kullanılmaktadır.

(7) Lokal Reaksiyon: Antineoplastik ilaçların çoğu i.v. yoldan verilir ve yine çoğu **vezikan** maddelerdir. İğne veya kateter ucunun ven içerisine yerleştirirken doku içine kaçması (ekstravazasyon) **lokal reaksiyon**a neden olur. Oluşan reaksiyon eritem, doku nekrozu veya ülserasyon gibi değişik şiddetlerde olabilir.

(8) Tümör Lizis Sendromu ve Hiperürisemi: Bazı antineoplastiklerle (pürin antimetabolitleri) tedavi sırasında aşırı miktarda çekirdek yıkılması sonucu vücutta biriken pürin bazlarından fazla miktarda ürik asit oluşmasına bağlı olarak gelişir. İdrarda biriken ürat kristalleri böbrek fonksiyonlarını bozar. Bu gibi durumlarda hastada hidrasyonun sağlanması ve hastaya tedaviden önce allopurinol gibi bir ksantin oksidaz inhibitörü verilmesi gereklidir (akut ürat nefropatisi gelişme olasılığını azaltır).

(9) Alerjik Reaksiyonlar: Bazı antineoplastik ilaçlara bağlı olarak alerjik reaksiyonlar görülebilir. Ürtiker, piretik reaksiyon (ateş), anjiyoödem ve hatta anafilaksi görülebilir. Bleomisin'e bağlı olarak piretik reaksiyon, taksanlara bağlı olara anafilaksi, etoposide bağlı olarak hipotansif reaksiyon meydana gelebilir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 29

K5-25 Kurul 2024–2025 • Soru 63

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده أساساً من درس 6. سلايد 29 هنا بيقول إن حاصرات 5-HT3 (زي granisetron) بتتستخدم لمنع قيء الكيماوي، بس الدوا التالت اللي اتضاف مع الديكساميثازون (aprepitant) مش مذكور في الملف ده. الإجابة في درس 6.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

63

Mesane kanseri nedeniyle yoğun kemoterapi alan 60 yaşında bir kadın hastada, doktorları kemoterapiye bağlı bulantı ve kusma için granisetron tedavisine başlıyor. Ancak ilaç, kemoterapi kürüne bağlı görülen güçlü ve geç dönem kusmalar için yeterli etkinliği sağlamadığı için hastaya granisetronun yanında deksametazon ve bir ilaç daha ilave ediliyor ve semptomlar geçiyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi granisteron ve deksametazon ile kombine edilen üçüncü ilaç olabilir?

- **A)** Aprepitant
- **B)** Meklizin
- **C)** Skopolamin
- **D)** Betahistin
- **E)** Metadon

7. **Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin neden olduğu emesise karşı kullanılan 5-HT$_3$ antagonistidir?**

A) Ondansetron ✓
B) Sumatriptan
C) Cisaprid
D) Fluoksetin
E) Buspirone

K4-25 Kurul 2024–2025 • Soru 7

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من كورول 4 (محاضرة السيروتونين ومضادات القيء)، بس سلايد 29 في الدرس ده بيقول إن ondansetron بيقفل مستقبلات 5-HT3 وبيتستخدم يمنع القيء بتاع الكيماوي.

الإجابة **A Ondansetron**

من الدرس **سلايد 29** 6. Antineoplastik İlaçların Ortak Yan Etkileri

6. Antineoplastik İlaçların Ortak Yan Etkileri



ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

(6) Bulantı ve Kusma (Emezis): **Emezis antineoplastiklerin en sık görülen yan tesiridir**. Kullanılan ilaca ve dozuna bağlı olmak üzere hafif bulantıdan dayanılmaz derecede şiddetli ve i.v. rehidratasyon gerektiren emezise kadar değişik şiddette olabilir. Bu etki önlenmediği takdirde ilacın kesilmesi gerekebilir. Antineoplastik ilaçların emetik etkisinin bu ilaçların mide-barsak mukozasında bulunan enterokromafin hücrelerden salınan serotoninin abdominal vagal afferent sinir uçlarındaki serotonin 5-HT$_3$ reseptörlerini uyarıp, beyin sapındaki kusma merkezini indirekt olarak uyarmasına bağlı olduğu ileri sürülmüştür. Antineoplastik ilaç veya metabolitlerinin beyin sapındaki «chemoreceptor trigger zone (CTZ)»nin direkt olarak uyarılmasının emezise katkısı vardır.

Emezisin önlenmesinde metoklopramid, fenotiyazin, proklorperazin ve haloperidol gibi dopamin antagonistleri, ondansetron, granisetron ve tropisetron gibi serotonin 5-HT$_3$ reseptör blokörleri kullanılmaktadır.

(7) Lokal Reaksiyon: Antineoplastik ilaçların çoğu i.v. yoldan verilir ve yine çoğu **vezikan** maddelerdir. İğne veya kateter ucunun ven içerisine yerleştirirken doku içine kaçması (ekstravazasyon) **lokal reaksiyon**a neden olur. Oluşan reaksiyon eritem, doku nekrozu veya ülserasyon gibi değişik şiddetlerde olabilir.

(8) Tümör Lizis Sendromu ve Hiperürisemi: Bazı antineoplastiklerle (pürin antimetabolitleri) tedavi sırasında aşırı miktarda çekirdek yıkılması sonucu vücutta biriken pürin bazlarından fazla miktarda ürik asit oluşmasına bağlı olarak gelişir. İdrarda biriken ürat kristalleri böbrek fonksiyonlarını bozar. Bu gibi durumlarda hastada hidrasyonun sağlanması ve hastaya tedaviden önce allopurinol gibi bir ksantin oksidaz inhibitörü verilmesi gereklidir (akut ürat nefropatisi gelişme olasılığını azaltır).

(9) Alerjik Reaksiyonlar: Bazı antineoplastik ilaçlara bağlı olarak alerjik reaksiyonlar görülebilir. Ürtiker, piretik reaksiyon (ateş), anjiyoödem ve hatta anafilaksi görülebilir. Bleomisin'e bağlı olarak piretik reaksiyon, taksanlara bağlı olara anafilaksi, etoposide bağlı olarak hipotansif reaksiyon meydana gelebilir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 29

15 Tıbbi Farmakoloji

SİNAN ŞERMET

Aşağıdaki immünomodülatör ilaçlardan hangisi kemik iliği transplantasyonunda yardımcı ilaç olarak ve kanser hastalarında nötropeninin hafifletilmesinde kullanılır? **12683**

- ✓ **A)** Filgrastim ✓
- **B)** Sirolimus
- **C)** Takrolimus
- **D)** Prednizon
- **E)** Sülfasalazin

F25 Final 2024–2025 · Soru 15

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من درس 10 (Hematopoetik Büyüme Faktörleri)، بس سلايد 27 في الدرس ده بيقول إن filgrastim بيتستخدم لنوتروبينيا الكيماوي. استخدامه في زرع النخاع مكتوب في درس 10.

الإجابة **A** Filgrastim

من الدرس **سلايد 27** 6. Antineoplastik İlaçların Ortak Yan Etkileri

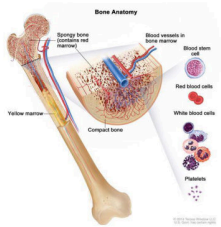
ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

6. Antineoplastik İlaçların Ortak Yan Etkileri

(1) Miyelotoksisite: Kemik İliğinin Baskılanması: Antineoplastik ilaçlar kemik iliğinde lökosit, eritrosit ve trombosit oluşturan hücreler üzerinde toksisite gösterirler. Bleomisin ve vinkristin bu açıdan toksisiteleri düşük ilaçlardır.

Lökosit 6 saat, Eritrosit 120 gün, Trombosit 5 gün yarılanma ömrüne sahiptir. Bu nedenle antineoplastik tedavi süresince lökopeni (nötropeni) çok belirgin derecede ve erken görülür.

Hastalarda gözlenen lökopeni derecesi bireysel farklılıklar gösterdiğinden, tedavi süresince hastaların kan hücresi sayıları izlenmelidir. Lökosit sayısı 1000/mm³'ün altına düştüğünde ciddi sistemik enfeksiyon riski ortaya çıkar, tedaviye uygun bir antimikrobik ilaç eklenmelidir. Trombosit sayısı 40.000/mm³'ün altına düşmesi durumunda ise ciddi kanama riski ortaya çıkmaktadır. İlaçların kemik iliğini baskılama dereceleri farklıdır. Döneme özgü ilaçlar; hızlı gelişen ve hızlı düzelen nötropeni yaparlar (metotreksat, vinblastin, pürin ve pirimidin antimetabolitleri), döneme özgü olmayan ilaçlar ise; genellikle daha yavaş gelişen, uzun süren ve geç düzelen kemik iliği baskılaması yaparlar (ör. nitrozüreler, busulfan ve mitomisin).



https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/bone-marrow
Erişim Tarihi: 18.10.2025)

Kemik iliğinin baskılanması antineoplastik ilaçlarla tedavide ilaca bağlı en önemli morbidite ve mortalite sebebidir. Ayrıca ilaçların bu etkisi onların dozlarını kısıtlayan en önemli etkendir.

Kemoterapide ciddi toksisite meydana geldiğinde ilaç dozlarının azaltılması gerekebilir. Kemik iliği baskılanması durumunda nötropeniye yönelik derinlik ve süreyi kısaltmak için hematopoietik büyüme faktörleri (filgrastim lenograstim, pegfilgrastim gibi) kullanılabilir.

Belli aralıklarla ilaç uygulaması ile bir önceki dozun oluşturduğu lökopeni tablosunun düzelmesi sağlanır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 27

59. Aşağıdakilerden hangisi antiemetikler için yanlıştır?

A) Metoklopramid seçici bir dopaminerjik D2 reseptör antagonistidir ve diğer reseptörler üzerine etkinliği yoktur

B) 5-HT3 reseptör antagonistleri kemoterapiye bağlı emezisde kullanılan başlıca ilaçlardır

C) Kortikosteroidler kemoterapiye bağlı emeziste 5-HT3 reseptör antagonistlerinin etkinliğini arttırırlar

D) NK1 antagonistleri yüksek derecede emetojenik kemoterapiden kaynaklanan akut ve geç dönemdeki bulantı ve kusmanın önlenmesinde 5-HT3 reseptör antagonistleri ve kortikosteroidlerle birlikte kullanılırlar

E) Histamin H1 antagonistleri (H1 antihistaminikler) hareket hastalığının tedavisinde kullanılırlar

K5-24 Kurul 2023–2024 • Soru 59

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده أساساً من درس 6. سلايد 29 هنا بيقول إن حاصرات HT3-5 هي اللي بتتستخدم في قيء الكيماوي (يعني B صح)، وبيذكر الـmetoklopramid مع مضادات الدوبامين، بس مش بيقول إنه بيأثر كمان على مستقبلات السيروتونين. الإجابة (A هي الغلط) في درس 6 و16.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

ملاحظات

79. Siklofosfamidin etkisi aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin aracılığı ile gerçekleşir?

A) Guaninin N7 pozisyonunda alkilasyonu ✓
B) Deoksitimidin monofosfat (dTMP) sentezinin blokajı
C) HER2/neu reseptörünün blokajı
D) Ribonükleotit redüktazın inhibisyonu
E) Topoisomeraz I' in inhibisyonu

K24 Kurul 2023–2024 · Soru 79

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده أساساً من درس 2 (Alkilleyici Ajanlar). بس سلايد 33 هنا بيحط siklofosfamid أول دوا في مجموعة الـ Alkilleyici، فالاختيار الوحيد اللي فيه alkilasyon هو الصح. تفاصيل الميكانيزم في درس 2.

الإجابة

A Guaninin N7 pozisyonunda alkilasyonu

من الدرس **سلايد 33** 8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

8. Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İlaç Ana Grupları			İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(A) Sitotoksik İlaçlar			
(1) Alkilleyici İlaçlar			siklofosfamid, ifosfamid, melfalan, klorambusil, busulfan, treosulfan, karmustin, lomustin, bendamustin
(2) Platin Koordinasyon Bileşikleri			sisplatin, karboplatin, oksaliplatin
(3) Antimetabolitler			(a) Folik asit analogları: metotreksat, pemetreksed, raltreksed (b) Pürin analogları ve benzeri inhibitörler: 6-merkaptopürin, pentostatin, fludarabin, klofarabin, nelarabin, kladribin (c) Pirimidin analogları: 5-fluorourasil, azasitidin, gemsitabin, kapesitabin, sitarabin, tegafur (urasilli)
Doğal Ürünler	(4) Mikrotübül İnhibitörleri	Vinka Alkaloidleri	vinkristin sülfat, vinblastin sülfat, vindesin sülfat, vinflunin, vinorelbin
		Taksanlar	paklitaksel, dozetaksel, karbazitaksel,
	(5) Topoizomereaz İnhibitörleri	Topoizomeraz I İnhibitörleri (Kompotesinler)	irinotekan, topotekan
		Topoizomeraz II İnhibitörleri (Epipodofilotoksinler)	etoposid, tenipozid
	(6) Antrasiklin Türevleri ve Diğer Sitotoksik Antibiyotikler		doksorubisin, daunorubisin, bleomisin, daktinomisin, epirubisin, idarubisin, mitoksantron, mitomisin
	(7) Farklı Etki Mekanizmalı İlaçlar		prokrabazin, dakarbazin, hidroksiüre, l-asparaginaz, abirateron asetat, enzalutamid, temozolamid

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 33

ملاحظات

72- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı azaltan bir peptid antagonistidir?

a) Metoklopramid
b) Aprepitant
c) Dekzametazon
d) Enalapril
e) Ondansetron

BF23 Bahar Final 2022–2023 · Soru 72

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده أساساً من درس 6. سلايد 29 هنا بيتكلم عن منع قيء الكيماوي بمضادات الدوبامين وحاصرات HT3-5 بس، والـaprepitant (مضاد مستقبل NK1) مش مذكور. الإجابة في درس 6.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

57- Küçük hücreli akciğer karsinom teşhisi konulan 63 yaşında erkek hasta, ilk kemoterapi döngüsü nedeniyle hastaneye başvuruyor. Bu hastada akut bulantı ve kusmayı en iyi şekilde önlemek için aşağıdaki üçlü ilaçlardan hangisi kombinasyon rejimi olarak seçilebilir?

a) Skopolamin, Deksametazon, Ondansetron
b) Ondansetron, Aprepitant, Deksametazon
c) Aprepitant, Skopolamin, Deksametazon
d) Betahistin, Proklorperazin, Dronabinol
e) Proklorperazin, Metoklopramid, Lorazepam

K5-22 Kurul 2021–2022 • Soru 57

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده أساساً من درس 6 (Antiemetik ajanlar). سلايد 29 هنا بيقول إن القيء أشهر أثر جانبي للكيماوي، وإن ondansetron وgranisetron (حاصرات HT3-5) ومضادات الدوبامين زي metoklopramid بيتستخدموا لمنعه، بس مفيش كلام عن الـaprepitant والديكساميثازون ولا عن التركيبة التلاتية. الإجابة في درس 6.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

Soru 90 0,5

Aşağıdaki ajanlardan hangisi insan keratinosit büyüme faktörünün rekombinan formudur ve ağır oral mukozitin insidansını ve süresini azaltmak amacıyla kullanılır?

En az bir doğru yanıt seçin

- (A) Mesna
- (B) Dakarbazin
- (C) DMSO
- (D) Palifermin
- (E) Hyaluronidaz

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 90

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده عن دوا بيقلل التهاب الفم (mukozit) اللي بيعمله الكيماوي، وده تبع موضوع الدرس (الأعراض الجانبية والأدوية المساعدة)، بس Palifermin مش مذكور في أي ملف شرح، فمفيش إجابة من الدرس. الإجابة حسب الامتحان (Palifermin) D.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

ملاحظات

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 92

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi şiddetli kemoterapi kaynaklı nötropeni gelişen hastada kullanılabilir?

En az bir doğru yanıt seçin

- (A) Eltrombopag
- (B) Sargramostim
- (C) K vitamini
- (D) Folik asit
- (E) IL-11 (oprelvekin)

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده أساساً من درس 10 (Hematopoetik Büyüme Faktörleri). سلايد 20 هنا بيقول إن عوامل النمو الدموية (filgrastim وlenograstim) بتتدّي بعد الكيماوي عشان تمنع النوتروبينيا، بس الـsargramostim (GM-CSF) نفسه مش مذكور. الإجابة في درس 10.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

42 - Aşağıdaki sitoprotektif ajanlardan hangisi rekombinant insan keratinosit büyüme faktörüdür ve antineoplastik ilaca bağlı olarak gelişen oral mukozitin tedavisinde kullanılır?

a) (●) Palifermin
b) ( ) Mesna
c) ( ) Sodyum tiyosülfat
d) ( ) Deksrazoksan
e) ( ) Amifostin

F21-1 Final 2020–2021 · Soru 42

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

نفس فكرة سؤال B21-2 بصيغة واختيارات تانية: دوا بيعالج التهاب الفم (mukozit) اللي بيعمله الكيماوي، وده تبع موضوع الدرس، بس Palifermin مش مذكور في أي ملف شرح. فمفيش إجابة من الدرس. الإجابة حسب الامتحان a (Palifermin).

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

ملاحظات